

지속적인 기억력 저하를 호소하는 80세 남성

증례

80세 남성이 약 1년 전부터 시작된 기억력 저하를 주소로 왔다. 전직 회계사였으며, 16년(대졸)의 학력을 가진 분이었다. 과거력에는 고혈압으로 amlodipine 5 mg을 복용 중이며, 치매 가족력은 없었다.

환자는 자신의 기억력이 또래보다 나쁘다고 생각한다고 했으며, 최근 특히 사소

한 것들을 자주 잊어버린다고 호소하였다.

구체적인 기억력 문제로는 돈을 빌려주고 기억하지 못한 일이 있었다고 하고, 골프 중 본인 순서를 잊고 공을 치려고 한 적이 있고, 골프 비용을 지불하지 않고 나오려고 한 적이 있다고 했다. 일상 생활에서 약을 간혹 빠트릴 때가 있고, 마트에서 이미 집에 있는 물건을 반복해서 구매하는

경우가 있었다고 했다. 그러나 스케줄이나 일정 관리, 소지품 관리에는 문제는 없었으며, 중요한 대화 내용 전달에는 어려움이 없었다. 보호자도 사소한 것들만 다시 물어보는 일이 종종 있다고 했다. 여전히 자가 운전을 하고 있으며, 주차와 길 찾기 등의 운전 능력은 변화가 없다고 했다. 은행 업무, 금전 관리도 독립적으로 수행하

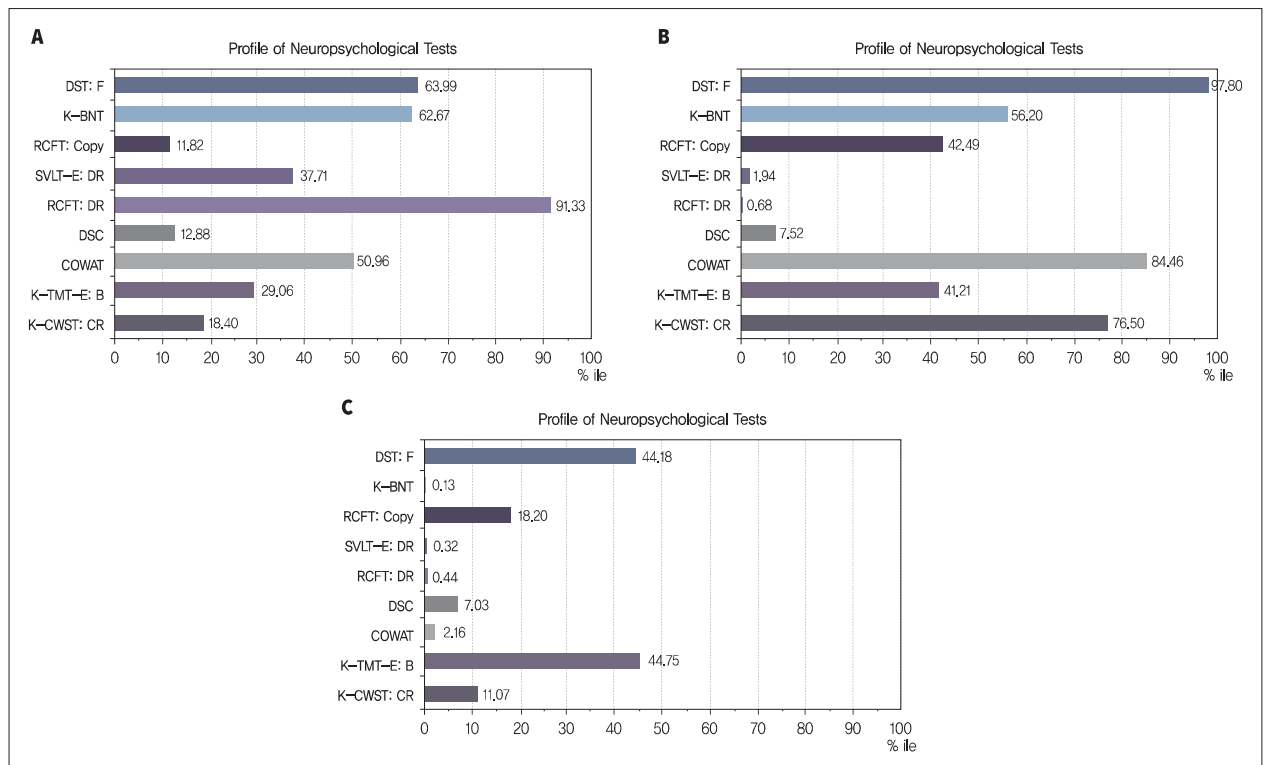


그림 1. 자세한 인지 기능 검사 결과

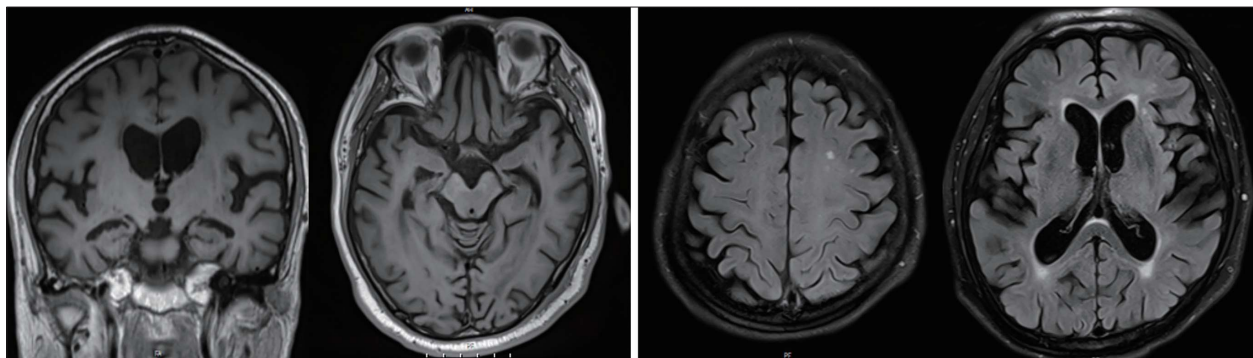


그림 2. 뇌MRI

고 있고, 사회 활동으로 정기적인 친구 모임 및 교회 활동에 참여하며, 매일 1시간씩 걷기 운동을 한다고 했다.

신체 진찰과 신경학적 검사에서는 특이 소견은 없었다. 처음 시행한 인지 기능 검사에서는 K-MMSE-2 29점(기억회상 3/3, 시간지남력 -1)으로 정상 범위였으며, SNSB-II(그림 1A)에서는 SVLT-DR 37.71퍼센타일, RCFT-DR 91.33퍼센타일로 정상 범위에 속했고, 인지 영역 별 그래프에서도 기억력 48.62퍼센타일을 포함하여 모든 영역에서 정상 범위, CDR 0.5(SOB 0.5), K-IADL 0.18였다.

뇌MRI(그림 2)에서는 전반적인 뇌위축과 함께 Scheltens' visual rating 좌/우측 모두 3 정도로 해마위축은 관찰되었으나, 심한 백질변성이나 뇌경색/뇌출혈은 없었다. APOE 유전자형은 ε3/ε4였다.

생활 교정 교육과 뇌 기능 개선제 처방을 시작하고 추적 관찰하였다. 외래 내원 때마다 기억력 저하를 호소하였고, 추적 관찰 6개월 이후에는 기억력이 더 떨어지는 것 같다고 호소하였지만 일상 생활 수행 능력의 변화는 없다고 하였고, 운전면허 갱신은 잘 되어서 여전히 운전, 금전 관리, 모

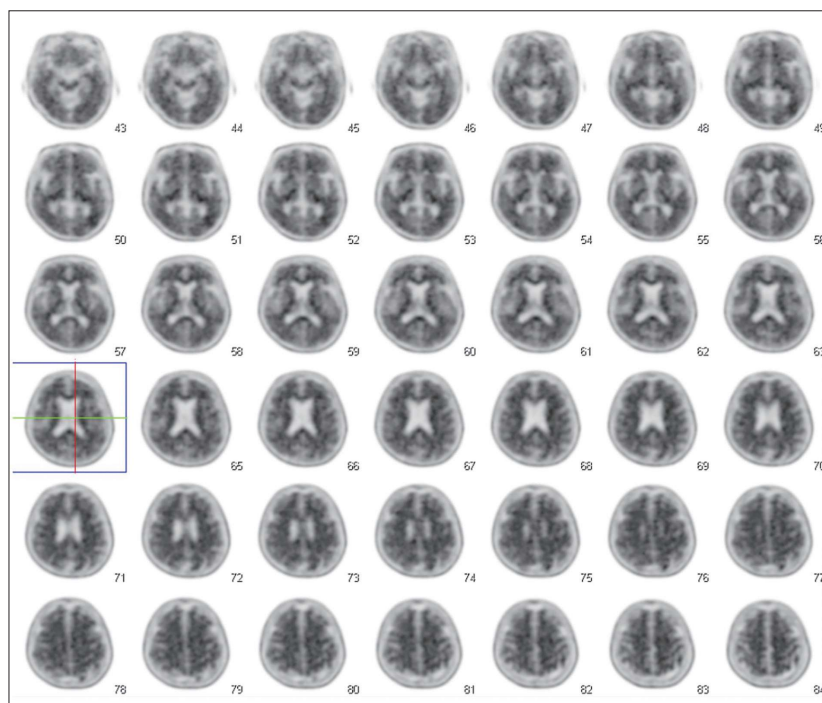


그림 3. Amyloid PET

임 참여 등은 문제없이 하고 있다고 했다. 10개월 째에 자세한 인지 기능 검사와 함께 florbetaben PET(그림 3)을 진행하였다. 두 번째 시행한 인지 기능 검사에서는 K-MMSE-2는 27점(기억회상 2/3, 시간지남력 -2)으로 정상 범위였으나, SNSB-II에서는(그림 1B) SVLT-DR 1.94, RCFT-

DR 0.68로 비정상 소견이 관찰됐고, 기억력 이외의 인지영역에서는 정상 범위, CDR 0.5(SOB 1.5), K-IADL 0.27였다. 아밀로이드 PET에서는 lateral temporal lobes, frontal lobes, posterior cingulate/precuneus, parietal lobes 모두에서 BAPL 3로 양성 소견을 보였다. 이에 따라 알츠하이

머병에 의한 기억상실형 단일 영역 경도 인지장애(amnestic, single domain MCI)로 전환됐다고 판단하여, 우선 비보험 donepezil 처방을 시작하였다. 환자는 donepezil 부작용은 없었고, 약물을 유지하면서 특별한 변화는 느끼지 못한다고 하였다. 외래 내원 때마다 기억력 저하는 여전히 호소하였으나, 추가 약화는 없는 것 같다고 하였고, 운전, 금전 관리를 포함하여 일상 생활에 큰 문제는 없다고 하였다. 다시 1년 후 세 번째 시행한 인지 기능 검사에서는 K-MMSE-2 26점(기억회상 1/3, 시간지남력 -2, 계산 -1)으로 역시 정상 범위였으나, SNSB-II에서는(그림 1C) SVLT-DR, RCFT-DR뿐만 아니라 K-BNT, COWAT에서도 7퍼센타일 이하로 저하가 관찰됐고, CDR 0.5(SOB 2), K-IADL 0.36였다. 기억상실형 다영역(amnestic, multiple domain MCI)으로 진단하고, donepezil 보험 적용으로 치료를 유지 중이다.

고찰

본 증례는 주관적 인지 저하에서 경도 인지장애로 비교적 빠르게 전환된 사례이다. 주관적 인지 저하 환자가 경도 인지장애로 전환되는 누적 비율은 약 5년에 20퍼

센트 정도로 보고되고 있다. 또한 주관적 인지 저하 환자에서 아밀로이드 PET 양성률은 약 20~40%로 보고되고 있다. 아밀로이드 PET 양성인 주관적 인지 저하 환자는 전임상 알츠하이머병으로 말할 수 있는데, 이 경우에도 알츠하이머병에 의한 경도 인지장애로 전환되는 데에는 약 10년 정도로 예측되었으나, 위험요인에 따라 그 속도는 달라질 수 있다. 고령, APOE ε4 carrier, 뇌척수액 검사에서 ptau 이상, 해마위축, 낮은 인지 예비능, 다양한 뇌혈관 질환 동반 여부 등이 진행을 빠르게 만들 수 있는 위험요인으로 보고되고 있다. 본 증례의 경우 고령, APOE ε3/ε4, 해마위축이 동반된 분으로, 주관적 인지 저하에서 경도 인지장애로 넘어가는데 관여하는 처음 인지 기능 검사 결과가 정상 범위에 속했다고 하더라도 진행 가능성을 염두에 두고 예정보다 일찍 인지 기능 검사 추적에 함과 동시에 아밀로이드 PET을 함께 시행하게 되었다. 본 증례처럼 주관적 인지 저하로 처음 진단했다고 하더라도 지속적인 기억력 호소가 있을 시는 위험요인을 확인하고, 아밀로이드 PET 등의 추가 검사를 고려하는 것이 진단 및 예후 평가에 도움이 될 수 있을 것으로 생각된다. 우리나라

에서도 항아밀로이드 항체 치료제가 상용화되면 알츠하이머병의 조기 진단 중요성이 확대될 수밖에 없기 때문에 주관적 인지 저하 환자의 조기 진단과 관리는 더욱 강조될 것으로 보이며, 지속적인 추적 관찰의 중요성이 더욱 부각될 것이다. 그러나 주관적 인지 저하 환자에서 아밀로이드 PET 양성률이 낮고 현재까지는 전임상 알츠하이머병의 경우 항아밀로이드 항체 치료제의 대상이 되지 않기 때문에 예정보다 일찍 또는 자주 인지 기능 검사를 추적해 보고 경도 인지장애로 전환되는 시점을 빨리 확인하는 것이 가장 중요하겠고, 아밀로이드 PET 검사 시행에 있어서는 비용 효과성을 따져서 가장 환자에게 도움될 시기에 진행하는 것을 고려할 필요가 있겠다.

향후 민감도, 특이도가 높은 혈액 바이오마커가 승인되어 상용화된다면 주관적 인지 저하 환자의 변화를 빠르고 경제적으로 파악하는데 도움이 될 것으로 예상된다.